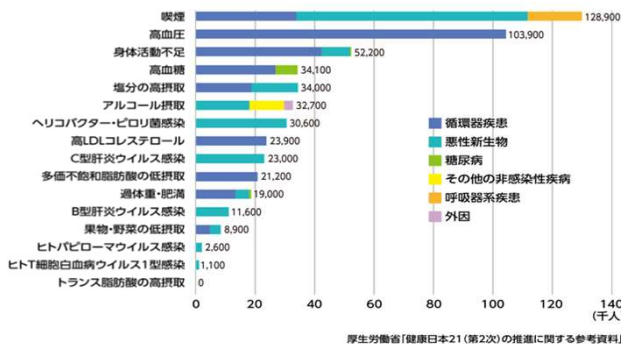


祥雲生と生活習慣病

兵庫県立三田祥雲館高等学校 経済・情報講座 17回生 堂馬 宇顕

研究目的

近年、我が国は生活習慣病を予防する風潮にある。しかし、日本人の死亡者数の約6割が生活習慣病患者である。下の図は、2007年の我が国における危険因子に関連する非感染性疾患と外因による死亡数であり、すべての年代を対象としたものであると思われる。



どのような理由でこのような危険因子が発生するのかという疑問が生じた。

そこで、この疑問の解消のため、以下の点の調査を行った。

リサーチクエスト

三田祥雲館高校の一部の生徒の生活習慣が全体的に良好でない場合、どのような習慣が乱れているのか。

また、何がそうさせているのか。

そもそも生活習慣病とは？

「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与する疾患群」のこと。

食習慣:インスリン非依存糖尿病、肥満、高脂血症(家族性のものを除く)、高尿酸血症、循環器病(先天性のものを除く)、大腸がん(先天性のものを除く)、歯周病等

運動習慣:インスリン非依存糖尿病、肥満、高脂血症(家族性のものを除く)、高血圧症等

喫煙:肺扁平上皮がん、循環器病(先天性のものを除く、慢性気管支炎、肺気腫、歯周病等

飲酒:アルコール性肝疾患等

発症の要因

1. 上述した生活習慣による「生活習慣要因」
2. 遺伝子異常や加齢などによる「遺伝要因」
3. 病原体、有害物質、ストレス(ストレスを与える刺激)などによる「外部環境要因」

参考文献

廣美里 (2003). 「高校生の生活習慣に関する研究—運動実践状況からみた生活習慣の状況に着目して—」. 吉田正, 村松常司, 廣紀江.

佐久間浩美 (2009). 「高校生のストレス反応と自己管理スキルとの関連に関する検討」. 高橋浩之, 竹鼻ゆかり, 久野佳子.

厚生労働省 (2019). 生活習慣病を知ろう! -スマート・ライフ・プロジェクト.

<https://www.smartlife.mhlw.go.jp/disease/2020> 年6月30日

厚生労働省 (2019). 身体活動・運動-スマート・ライフ・プロジェクト.

<https://www.smartlife.mhlw.go.jp/disease/exercise/2020> 年6月30日

研究方法

三田祥雲館高校の17回生を対象にアンケートを実施する。

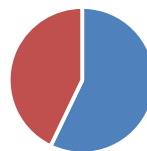
アンケートの内容は食習慣、睡眠習慣、運動習慣と、生活習慣病発症の可能性を抑制するにあたって重要と思われる自己管理スキルについての質問項目である。

研究の途中結果

ここでは、調査結果を掲載する。

各質問項目ごとに回答の傾向が異なるが、ここでは各分野の全質問の回答の総合結果から、各習慣が良い人と悪い人の傾向を図に表した。

睡眠習慣



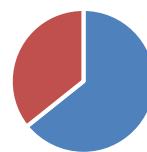
■ 良い(57%) ■ 良くない(43%)

適正体重



■ 良い(68%) ■ 良くない(11%)
■ 未回答(21%)

運動習慣



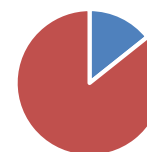
■ 良い(64%) ■ 良くない(36%)

食習慣



■ 良い(50%) ■ 良くない(50%)

自己管理スキル



■ 良い(14%) ■ 良くない(86%)

自己管理スキルが豊富な人は、ストレスによるストレス反応の表出が弱まるとされている。

ここまでの考察

睡眠習慣や運動習慣などから、身体的な健康に気を使って生活している生徒が半分以上を占めている。しかし、自己管理スキルの高い生徒はほとんどいないので、普段から計画を立てて生活している生徒は少ないと思われる。調査を行った生徒のほとんどが意識せずに生活習慣を健康を害さないように保っていると考えられる。